



経鼻胃管のX線位置確認 スタイレットは 「入れたまま」か 「抜いてから」か

スタイレット（ガイドワイヤー）／エビデンス・国内外ガイドライン・添付文書からの考察

スタイレット、
入れたまま撮る？
抜いてから撮る？

結論

確認するまで抜かない＝入れたまま撮影が標準

本日のアジェンダ

- | | | | |
|----------|------------|----------|-------------|
| 1 | 何が論点か | 2 | 標準はどちらか |
| 3 | 決め手＝再挿入は禁忌 | 4 | 「抜いてから」論の検討 |
| 5 | 日本と英国の違い | 6 | 正しい確認フロー |
| 7 | X線の限界と今後 | | |

論点：2つの立場

案	手順	位置づけ
A案	スタイレット挿入下でX線撮影 → 確認後に抜去	標準・多数派
B案	スタイレットを抜いてから撮影	少数意見

B案の問題意識は**抜去時に先端がずれる懸念**にある。



**スタイレット等は、チューブが正しい
位置に留置されたことを確認するまで
引き抜かないこと**

— PMDA 経腸栄養用チューブ 添付文書改訂指示

スタイレット再挿入は禁忌

スタイレット再挿入 禁忌

一度抜いたスタイレットは、体内のチューブへ入れ直さない。

危険 側孔から先端が飛び出し、消化管壁を損傷するおそれがある。

だから抜く前に確認する — 抜去は不可逆な操作

「抜いてから撮るべきでは？」

✕ 抜去時に先端がずれるので、抜いてから撮るべきだ

○ 問題意識は妥当。だが誤留置が分かってても再挿入で修正できず、運用として破綻する

確認方法は日本と英国で違う

国	第一選択	備考
日本	X線（最も信頼できる確認）	pH測定は補助・気泡音は単独では不可
英国	吸引液pH ≤ 5.5	判定できない場合にX線を用いる

正しい確認フロー

- 1 STEP 1 スタイレットを入れたまま挿入する
- 2 STEP 2 吸引液の性状・pHを確認（補助・気泡音のみは不可）
- 3 STEP 3 入れたままX線で先端確認（スタイレット付きは特に望ましい）
- 4 STEP 4 誤留置なら微調整、またはチューブごとやり直し（再挿入しない）
- 5 STEP 5 確認後ゆっくり抜去・廃棄する
- 6 STEP 6 外部露出長をマーキングする

1.9%

⚠ 盲目的挿入で気管・肺系へ誤留置

数字で見る根拠

pH ≤ 5.5

胃内と判断する目安（英国は第一選択・日本は補助）

18cm

肺内誤挿入例で先端が気管分岐部より深部（中央値）

Slingerland-Boot R, et al. Clin Nutr 2021;40(8):5000-5007／Taylor S, Manara AR. Br J Radiol 2021;94:20210432

X線での正しい判定基準（RCR）

入れたまま撮る場合も、
正しく胃内を確認できる撮影・読影でなければ意味がない。

📋 英国王立放射線科医会（RCR）の基準

- ✓ チューブが画像下端まで写る露出に調整する
- ✓ 横隔膜下の腹部まで含めるよう低めにセンタリングする
- ✓ 正中を下降し気管分岐部を越えて左に偏位、胃泡内へ達するか確認する

事後X線にも限界がある

「入れたまま撮影」を推奨しても、事後のX線確認そのものに限界がある。

⚠ 監査データ（891例・1934件のX線）

- ✓ 胃内確認は85%だが「注入して安全」は73%にとどまる
- ✓ 報告の2.2%が肺内・中央値18cm・7例の気胸を防げず
- ✓ X線確認で51%が栄養・薬剤を2時間以上遅延
- ✓ 今後はガイド下留置（電磁・直視・IRIS）へ

今日の3つの持ち帰りポイント

01

入れたまま 撮影が標準

正しい位置を確認するまでスタイレットは抜かない。

02

再挿入は禁忌

抜去は不可逆な操作。確認前に抜くと修正できない。

03

ずれ懸念は 二次確認で

ゆっくり抜去し、pH・外部マーキングで管理する。

参考文献

- [1] PMDA. 経腸栄養用チューブ添付文書改訂指示.
- [2] 日本医療安全調査機構 提言第6号 (2018) .
- [3] NHS England / NPSA. NG/OGチューブ位置確認.
- [4] RCR. Chest x-ray confirmation of NG tube.
- [5] Taylor S, Manara AR. Br J Radiol. 2021;94:20210432.
- [6] Slingerland-Boot R, et al. Clin Nutr. 2021;40:5000-5007.



ご利用にあたってのお願い

本資料は**医療従事者向けの学習教材**であり、特定の患者への診療行為を指示するものではありません。

実際の手技は**自施設のマニュアルと使用製品の添付文書**を最優先してください。

ご視聴ありがとうございました

これからも、信頼できる医療情報をわかりやすくお届けしてまいります。

引き続き、**医知創造ラボ**をよろしくお願いいたします。